



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Salute & Professioni sanitarie

Le strade dentro l'area · Guida 2

Guida di orientamento — KIREO

Guida 2 · Le strade dentro l'area — 2026

Hai capito che l'area **Salute & Professioni sanitarie** ti interessa. La domanda successiva non è «voglio lavorare in ospedale?», ma: **che tipo di problema sanitario mi viene naturale affrontare?** C'è chi vuole capire cause e diagnosi, chi stare vicino alle persone nella cura quotidiana, chi recuperare funzioni perdute, chi lavorare con macchine e dati, chi prevenire prima che il problema arrivi.

*In Italia lo Stato riconosce **31 professioni sanitarie** con obbligo di iscrizione all'Ordine, per circa **1,5 milioni** di professionisti (Ministero della Salute): medicina e infermieristica sono solo due delle strade possibili.*

I rami dentro l'area

Cura clinica e decisioni mediche. Capire il quadro di una malattia: raccogliere sintomi, scegliere esami, formulare diagnosi, decidere terapie e seguire l'evoluzione. Qui stanno soprattutto medicina, chirurgia e odontoiatria — ma il medico non fa tutto da solo: lavora con infermieri, tecnici, farmacisti, fisioterapisti e psicologi. Attitudine: **analitica, responsabile, capace di decidere anche con informazioni incomplete**, per chi tollera studio lungo e il peso delle decisioni.

Assistenza infermieristica e ostetrica. La cura diretta e continuativa. L'infermiere è responsabile dell'assistenza (prevenzione, terapia, educazione, monitoraggio dei parametri, sicurezza, comunicazione con famiglie ed équipe), non «dà una mano al medico». L'ostetrica/o segue gravidanza, parto, puerperio e salute riproduttiva. Attitudine: **relazionale e operativa**, con osservazione dei dettagli e capacità di agire sotto pressione.

Riabilitazione, autonomia e benessere funzionale. Aiutare a recuperare, mantenere o adattare le funzioni della vita quotidiana: muoversi, parlare, mangiare, tornare autonomi. Qui stanno fisioterapista, logopedista, terapeuta occupazionale, neuropsicomotricista, podologo, ortottista, educatore professionale. Attitudine: **relazionale, pratica e paziente**, per chi accetta miglioramenti piccoli, lenti e diversi da persona a persona.

Diagnostica, tecnologie e dati sanitari. All'incrocio tra salute, strumenti e precisione: tecnico di radiologia (TSRM), di laboratorio biomedico, di neurofisiopatologia, audiometrista, audioprotesista, igienista dentale, dietista. Il lavoro è tecnico ma quasi mai isolato: ci sono pazienti, medici, procedure e responsabilità sulla qualità. Attitudine: **analitica e operativa**, con gusto per procedure, strumenti e controlli.

Prevenzione, salute pubblica e sicurezza. Intervenire prima che un rischio diventi un problema grave: assistente sanitario e tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (igiene, alimenti, sicurezza, vaccinazioni, educazione alla salute). Attitudine: **analitica, concreta e orientata alle regole**, con interesse per dati, territorio, ispezioni e responsabilità collettiva.

Supporto socio-sanitario e cura quotidiana. Vicino alle persone fragili nella vita reale: l'operatore socio-sanitario (OSS) collabora con l'équipe nell'assistenza di base (igiene, comfort, mobilitazione, pasti, osservazione). Non è una professione ordinistica, ma è fondamentale. Attitudine: **molto relazionale e operativa**, con resistenza fisica, rispetto e lavoro di squadra.

Come cambia la giornata da un ramo all'altro

Ramo	Dove e con che ritmo	Cosa pesa di più
Cura clinica e medica	Ambulatorio, reparto, pronto soccorso, sala operatoria o territorio	La decisione clinica e la sua comunicazione

Ramo	Dove e con che ritmo	Cosa pesa di più
Infermieristica e ostetricia	Turni frequenti in ospedale; anche territorio e ambulatori	La continuità della cura e la relazione
Riabilitazione	Studi, palestre, reparti, scuole, domicilio; incontri programmati	Il percorso nel tempo, uno-a-uno
Diagnostica e tecnologie	Laboratori, radiologia, sale diagnostiche; protocolli stretti	La precisione tecnica e la sicurezza
Prevenzione e salute pubblica	Territorio, aziende, servizi, scuole; meno urgenza clinica	Evitare che il problema inizi o si diffonda
Supporto socio-sanitario	Strutture residenziali, ospedali, domicilio; attività fisiche	La cura quotidiana e la dignità della persona

La differenza non è solo il luogo: in medicina e diagnostica pesa la decisione clinica o tecnica; in infermieristica e OSS la continuità; nella riabilitazione il percorso nel tempo; nella prevenzione l'evitare che il problema nasca.

E quasi nessun ramo è davvero «da soli»: anche il lavoro più tecnico richiede consegne, confronto, documentazione e responsabilità condivise. L'idea del professionista che risolve tutto da solo è poco realistica.

Due o tre giornate vere

Infermiere in reparto. Si parte dal passaggio di consegne (condizioni, terapie, esami, priorità), poi si organizza l'assistenza, si controllano i parametri, si gestiscono e verificano le prescrizioni, si comunica con medici, OSS, fisioterapisti e famiglie. La parte poco visibile: documentare, preparare le dimissioni, aggiornare il piano assistenziale, spiegare le procedure. Non è fatta solo di emergenze, ma di priorità che cambiano, attenzione ai dettagli e rapporto umano — fisicamente e mentalmente impegnativa.

Tecnico di radiologia (TSRM). Prima della procedura verifica identità, richiesta, preparazione e condizioni della persona; durante una radiografia, TAC o risonanza la posiziona, le spiega cosa accadrà, usa apparecchiature complesse e acquisisce le immagini secondo protocolli. Il lato invisibile: gestione della dose e della protezione, qualità delle immagini, procedure informatiche, confronto col radiologo e attenzione a chi è spaventato o dolorante. Non interpreta il referto al posto del medico: garantisce un'indagine tecnica affidabile e sicura.

Medico di medicina generale. Alterna visite, valutazione dei sintomi, prescrizioni, certificazioni, richieste di esami, confronto con gli specialisti e visite domiciliari. La parte meno visibile è la continuità: ricostruire la storia clinica, capire quali farmaci una persona assume davvero, coordinare gli specialisti, interpretare i referti nel contesto di vita e decidere quando un problema si gestisce sul territorio e quando no. È ragionamento clinico e relazione lunga nel tempo, con molta responsabilità organizzativa.

Quale percorso porta a quale ramo

Medicina, odontoiatria e professioni sanitarie

- Medicina e chirurgia e Odontoiatria: lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni. Dal 2025/26 l'accesso in italiano è regolato dal «semestre filtro» (primo semestre a iscrizione libera, poi graduatoria nazionale di merito).
- Le professioni sanitarie (infermieristica, ostetricia, fisioterapia, logopedia, radiologia, laboratorio, dietistica, igiene dentale, prevenzione...) sono lauree triennali abilitanti, ad accesso programmato (prova nazionale fissata al 16 settembre 2026).
- Dopo il titolo e l'iscrizione all'Ordine si accede alla professione; poi ci sono magistrali, master e formazione continua.

ITS Academy e OSS

- Gli ITS Academy (1.800-2.000 ore, almeno 30% di tirocinio) nell'area «Nuove Tecnologie della Vita» portano a biotecnologie, dispositivi medici, produzione farmaceutica, qualità e dati — non alle professioni cliniche regolamentate.
- Per fare l'OSS serve un corso regionale autorizzato: almeno 1.000 ore in 9-18 mesi. È un ruolo diverso dall'infermiere, non una sua «versione ridotta».

Attenzione: il confine tra rami non è netto. Un fisioterapista può lavorare in ospedale, nello sport, con anziani, bambini o persone neurologiche; un infermiere in emergenza, sala operatoria, comunità, pediatria o salute mentale. Il corso definisce la professione di partenza, ma tirocini, primi lavori e formazione successiva definiscono il contesto reale.

Come capire quale ramo ti somiglia

Poche domande per orientarti tra i rami — la chiave è il **tipo di problema** che ti viene naturale affrontare, non il prestigio del ruolo.

- **Cura clinica e medicina** — se ti attira capire il perché dei sintomi, collegare molte informazioni e assumerti decisioni complesse. Ti interessa più individuare il problema o seguire la persona ogni giorno?
- **Infermieristica e ostetricia** — se ti interessa la cura quotidiana, osservare i cambiamenti e stare accanto a persone e famiglie. Riesci a restare presente quando qualcuno è spaventato, dolorante o arrabbiato?
- **Riabilitazione** — se ti soddisfa vedere miglioramenti gradualmente e adattare il percorso. Ti va bene aiutare a recuperare un gesto o una parola anche se servono settimane?
- **Diagnostica e tecnologie** — se ti piacciono strumenti, precisione, procedure e dati. Ti interessa fare bene un passaggio tecnico ripetibile, sapendo che un dato affidabile aiuta altri a decidere?
- **Prevenzione** — se pensi a come evitare rischi per molte persone. Preferisci intervenire su un problema già presente o cambiare condizioni e comportamenti per ridurlo prima?
- **Supporto socio-sanitario** — se il contatto quotidiano con persone fragili ti sembra importante e sei disposto ad attività fisiche e pratiche, con rispetto.

In tutte le professioni sanitarie l'errore conta, ma cambia il tipo di peso: nella diagnostica la precisione tecnica; nell'assistenza la continuità e l'osservazione; nella medicina la decisione clinica; nella riabilitazione il non promettere risultati irrealistici; nella prevenzione la responsabilità verso gruppi e comunità.

Le idee sbagliate sui rami

Si dice...	In realtà
Per curare davvero devi fare Medicina.	Medicina decide diagnosi e terapie, ma l'assistenza e il recupero dipendono da un'équipe: infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici, dietisti, OSS. Le professioni sanitarie riconosciute sono 31, non una.
Infermieristica è solo punture ed eseguire ordini.	L'infermiere identifica i bisogni, pianifica, gestisce e valuta gli interventi, oltre ad applicare le prescrizioni. Ci sono procedure tecniche ma anche educazione, relazione, valutazione e organizzazione.
Fisioterapia = sport o massaggi.	Comprende prevenzione, valutazione funzionale e riabilitazione in molti contesti: neurologia, ortopedia, respiratorio, anziani, bambini, cronicità. Lo sport è solo una delle aree.
Tecnica e tecnologia = poco contatto umano.	Un tecnico di radiologia prepara, posiziona, informa e rassicura persone spesso preoccupate. La precisione tecnica non elimina la relazione: la rende più responsabile.
L'OSS è un lavoro semplice.	Ha formazione specifica, responsabilità di collaborazione e forte impatto sulla dignità quotidiana delle persone. Richiede presenza, resistenza, osservazione e rispetto dei confini del ruolo.

Questa è una guida per orientarti dentro l'area, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire quale ramo ti somiglia è provarlo: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- Ministero della Salute — «Professioni sanitarie» ed «Elenco professioni».
- FNOPI — D.M. 739/1994, profilo professionale dell'infermiere.
- FNOFI — «Fisioterapia e attività motoria» (2026); FNO TSRM e PSTRP — documento sul tecnico di radiologia.
- MUR — D.M. 941/2026 (semestre filtro Medicina/Odontoiatria) e date delle prove di ammissione 2026/2027.
- Conferenza Stato-Regioni — Accordo del 3 ottobre 2024 (corso OSS); MIM — pagina ITS Academy.